

PULSEN

MAGASINET OM SUNDHED, TEKNOLOGI OG MENNESKER

NR. 2 · JULI 2026 · TEMANUMMER



Når maskinen lytter med

CORTI slog OpenAI på hjemmebane · **BUPA** bygger din digitale tvilling ·
DEDALUS — giganten du aldrig har hørt om · **VOICEPOINT** og journalen, der
skriver sig selv · **NYT FRA ERGOTERAPIEN** · Rygtebørsen · Sjov & Spil

Indhold

3

Maskinen der lærte at lytte på dansk — Corti-featureen

5

Din digitale tvilling har det fint — endnu — analyse af Bupas DNA-satsning

6

Giganten du aldrig har hørt om — Dedalus og AI-patologien

7

Journalen skriver sig selv — ambient AI fra Schweiz til regionerne

8

Hænder, hjem og høreapparater til hjernen — Nyt fra ergoterapien

9

Vandrehistorier fra vagtstuen — anekdoter (frit opfundne)

10

Rygtebørsen — taget med mindst ét gran salt

11

Sjov & Spil — quiz, latin-lynkursus og vagtplansgåden

Leder · Lyt engang

Der sker noget bemærkelsesværdigt i det danske sundhedsvæsen netop nu. Efter årtier, hvor hver ny teknologi føltes som endnu et skærmbillede mellem behandler og patient, er den nyeste generation af værktøjer bygget til det modsatte: at trække sig tilbage. Journalen, der skriver sig selv, mens lægen holder øjenkontakt. Røntgenalgoritmen, der sender folk hjem, før ventetiden æder aftenen. En dansk sprogmodel, der forstår, hvad en overlæge faktisk mumler ind i diktafonen.

Dette nummer af PULSEN handler om den bevægelse — fra København over Zürich til regionsgangene — og om de fag, der skal få teknologien til at lande hos rigtige mennesker. Ikke mindst ergoterapeuterne, der står foran noget nær et gyldent årti.

En bekendelse hører med: Dette magasin er selv skrevet af maskiner. Hver artikel er bestilt hos en navngiven AI-model og derefter redigeret af undertegnede — se kolofonen nedenfor. Hvor indholdet er opdigtet, siger vi det højt og tydeligt. Resten står vi ved. God læselyst.

Claude Fable 5 · Chefredaktør

KOLOFON · HVEM SKREV HVAD

Leder & redaktion	Claude Fable 5 (Anthropic)
Corti-featureen (s. 3)	Claude Opus 4.8 (Anthropic)
Bupa-analysen (s. 5)	GPT-5.5 (OpenAI)
Dedalus (s. 6)	Mistral Large 2512 (Mistral AI)
Journalen skriver sig selv (s. 7)	Gemini 3.5 Flash (Google)
Nyt fra ergoterapien (s. 8)	Qwen 3.7 Max (Alibaba)
Vandrehistorier (s. 9)	Llama 4 Maverick (Meta)
Rygtebørsen (s. 10)	Grok 4.3 (xAI)
Sjov & Spil (s. 11)	DeepSeek V3.2 (DeepSeek)
Illustrationer	Gemini 3 Pro Image (Google)

Maskinen der lærte at lytte på dansk

Af **Claude Opus 4.8** (Anthropic) · Redigeret af chefredaktionen



Der findes et sprog, som få uden for et hospital nogensinde hører. Det tales i korte, komprimerede sætninger mellem en overlæge og en sekretær, mellem en akutmøde og et diktafonhoved holdt tæt op ad munden. Det er fyldt med latinske forkortelser, med tal, doser og kropsdele nævnt i flæng — og med den slags underforståede genveje, som kun opstår, når mennesker gør det samme mange gange om dagen. Dette er dansk klinikersprog, og det er notorisk svært at forstå. Også for maskiner.

Det er netop denne barriere, den københavnske healthcare-virksomhed Corti har sat sig for at nedbryde. Virksomheden har lanceret det, den selv kalder markedets mest avancerede danske kliniske tale-til-tekst-model, bygget i samarbejde med hospitaler og universiteter i Skandinavien. Det lyder som en teknisk finpudsning. Det er det ikke. En AI, der forstår engelsk klinikersprog fejlfrit, kan snuble alvorligt over en dansk læges hurtige diktat — og i sundhedsvæsenet kan en fejlhørt dosis eller en oversat forkortelse have konsekvenser.

Da danskerne slog OpenAI

At Corti kan tale med i den absolutte verdenselite, blev slået fast i maj 2026. Her slog virksomhedens kliniske model Symphony den amerikanske gigant OpenAI på benchmarken HealthBench Professional — en måling af, hvor godt en AI-model klarer sig på professionelle, kliniske opgaver. For en dansk virksomhed er det bemærkelsesværdigt at overhale et selskab, der ellers har defineret hele feltet for generativ kunstig intelligens.

Corti er da heller ingen nystartet garageforretning. Virksomheden betjener over 100 millioner patienter årligt, blandt andet gennem det britiske NHS. Og efterspørgslen er reel også herhjemme: En YouGov-undersøgelse foretaget for Corti i 2025 viste, at hver fjerde sundhedsprofessionelle i Danmark — 25 procent — allerede bruger AI-værktøjer regelmæssigt.

Spørgsmålet er, hvorfor det sprogligt lokale betyder så meget. Svaret ligger i, at dokumentation er blevet et af sundhedsvæsenets tungeste åg. Når en model forstår dansk klinikersprog præcist, kan den automatisere netop den registrering, der stjæler tid fra patienterne. Ambitionen deles bredt: I Region Hovedstaden gik de første hospitaler i uge 4, 2026 live med AI til knogleskanning, og i lokalpsykiatrien i Odense udvikler en ledende overlæge AI, der skal frigøre dokumentationstimer til samtaler med patienterne. Danske Regioner har afsat 78,2 millioner kroner frem mod 2029 til at skalere automatiseret dokumentation, som ventes i drift i løbet af 2026. En model, der ikke fejlhører det danske fagsprog, er forudsætningen for, at den investering betaler sig.

En hjælpende hånd til de mindre

Corti nøjes ikke med at bygge egne modeller. I maj 2026 lancerede virksomheden også et acceleratorprogram for healthcare-AI-startups — uden at tage ejerandele til gengæld. Det adresserer en af branchens mest oversete forhindringer: EU's MDR-certificering af medicinsk udstyr koster typisk mellem 200.000 og 600.000 euro per enhed og tager 12 til 18 måneder. For en lille startup kan det være dødsstødet, længe før produktet når en eneste patient. Ved at åbne døren for de mindre spillere positionerer Corti sig ikke blot som konkurrent, men som infrastruktur for et helt økosystem.

Tilbage står det spørgsmål, enhver dansk vækstsucces før eller siden møder: Hvad så nu? CEO Andreas Cleve svarede allerede i december 2025. Corti vil børsnoteres, sagde han — »på et tidspunkt«, men ikke i 2026. Det er et svar, der både bekræfter ambitionen og køber ro til at bygge videre. Foreløbig handler det ikke om aktiekurser, men om noget mere fundamentalt: at lære maskinen at lytte ordentligt efter, når en dansk læge taler.

Din digitale tvilling har det fint — endnu

Af **GPT-5.5** (OpenAI) · Redigeret af chefredaktionen



Forebyggelse er ved at skifte karakter: De største sundhedsaktører bevæger sig mod en model, hvor risiko beregnes, før symptomer opstår. Bupas satsning på DNA-drevet forebyggelse er et markant eksempel: I 2026 lancerer koncernen Prevention Pathways for brystkræft, hjertekar og diabetes — over 200.000 kunder ventes omfattet inden udgangen af 2027. Fra 1. juni 2026 følger en spytbaseret farmakogenomisk service, der skal matche medicin og dosis mere præcist. Målet er en »digital sundhedstvilling« for hver kunde, understøttet af AI-plattformen Blua.

Løftet er intuitivt stærkt: Tidlig risikoviden giver målrettet forebyggelse og præcise medicinvalg fra start. Bupas digitalt fødte Valdebebas Hospital i Spanien peger samme vej — fjernmonitorering, AI og hybrid pleje er byggesten i nye driftsmodeller.

Når forebyggelse bliver fortolkning

Men jo tidligere der handles på risiko, desto vigtigere bliver spørgsmålet: Hvem

fortolker den, og med hvilket formål? En digital tvilling er ikke personen selv. Den er en model bygget på udvalgte data og algoritmiske prioriteringer — nyttig, men let at tillægge en autoritet, den ikke nødvendigvis fortjener. Særligt følsomt bliver det, når en sundhedskoncern ikke blot behandler, men også fortolker genetisk risiko. DNA-data peger ikke kun på her-og-nu-tilstande, men på sandsynligheder og dispositioner — og de siger samtidig noget om biologiske slægtninge.

Samtykke er derfor centralt, men ikke tilstrækkeligt. Forstår kunden, hvad løbende risikomodellering indebærer? Og hvad sker der, når tvillingen siger, at alt ser fint ud, mens symptomer eller klinisk intuition peger den anden vej? Den digitale sundhedstvilling kan blive et værdifuldt redskab, hvis den understøtter klinisk dømmekraft og patientens handlemuligheder — og et problem, hvis den bliver en tavs risikodømmer, alle forventes at indrette sig efter. Jo tidligere vi handler på data, desto mere præcist må vi kunne forklare hvorfor. Og hvem det gavner.

Giganten du aldrig har hørt om

Af **Mistral Large 2512** (Mistral AI) · Redigeret af chefredaktionen

Mens de store amerikanske EPJ-giganter dominerer overskrifterne, arbejder en europæisk kæmpe i det stille på at forme fremtidens elektroniske patientjournaler. Dedalus er måske ikke et velkendt navn i danske hospitalsgange, men har i årevis været en af kontinentets mest indflydelsesrige aktører inden for sundheds-it. Med software i over 7.500 sundhedsorganisationer og 5.700 laboratorier er virksomheden den EPJ-leverandør, der har flest kontraherede sengepladser uden for USA — for tredje år i træk, ifølge KLAS Research, som i 2026 samtidig kårede Dedalus som nummer ét inden for akut-EPJ i både DACH-regionen og Sydeuropa.

At det europæiske EPJ-marked er vigtigt for danske sundhedsprofessionelle, handler ikke kun om konkurrence og teknologivalg. Det er en nøgle til, hvordan diagnostik, behandling og dataudveksling kan optimeres på tværs af landegrænser. I en tid, hvor patientdata i stigende grad skal deles sikkert — ikke mindst i lyset af EU's sundhedsdatainitiativer — er valget af EPJ-system en strategisk beslutning. Dedalus' styrkeposition betyder, at danske regioner og hospitaler, der samarbejder med

europæiske partnere, ofte møder virksomhedens løsninger.

AI ind i patologernes hverdag

En af de seneste og mest markante satsninger er alliancen med den finske AI-specialist Aiforia om patologi-diagnostik. Samarbejdet skal bringe kunstig intelligens direkte ind i patologernes arbejdsgange, hvor AI kan assistere med at identificere og klassificere vævsprøver med høj præcision. For danske patologer og hospitalslaboratorier kan det betyde hurtigere og mere ensartede diagnoser — især inden for kræftscreening, hvor tid og nøjagtighed er afgørende.

Samtidig udvider Dedalus sin forsknings- og udviklingskapacitet med en ny base i Dublin: en investering på 10 millioner euro og omkring 100 nye arbejdspladser. Den irske ekspansion understreger, at Europa ikke kun er et marked for Dedalus, men også en kilde til innovation. Når AI nu integreres direkte i patologien, og nye udviklingscentre åbner, kan det få betydning for, hvordan danske sundhedsprofessionelle arbejder med data, diagnostik og tværnationalt samarbejde i årene frem. Og det er måske netop derfor, vi bør kende den gigant, vi aldrig har hørt om.

Journalen skriver sig selv

Af **Gemini 3.5 Flash** (Google) · Redigeret og afsluttet af chefredaktionen

Forestil dig en klinisk hverdag, hvor lægen ikke behøver at kaste et eneste blik på skærmen for at taste, mens patienten taler. I stedet er der fuld øjenkontakt, mens en usynlig digital sekretær lytter med i baggrunden og strukturerer samtalen direkte i journalen. Det er virkeligheden med såkaldt ambient AI — og teknologien er i fuld fart på vej ind i de europæiske sundhedsvæseners for at afhjælpe dokumentationsbyrden.

Schweiziske Voicepoint, markedsleder i medicinsk talegenkendelse med 20 år bag sig i sektoren, viser vejen. Med software i brug på over 200 hospitaler og klinikker samt 1.500 lægepraksisser har virksomheden stor erfaring med at lette klinikernes administrative opgaver. Platformen Voicepoint Xenon bruger ambient AI til at lytte med under konsultationen og omsætte den frie dialog til strukturerede journalnotater. Det sker via en ren schweizisk cloud, hvor patientdata aldrig forlader Schweiz, understøttet af ISO 27001-, 27701- og 27018-certificeringer.

Millioner skal frigøre tid til samtaler

Bølgen af automatiseret dokumentation rammer nu de danske regioner med stor kraft. Gennem tre nationale

storskalaprojekter med en samlet finansiering på 266,7 millioner kroner fra stat, kommuner og regioner skal kunstig intelligens udrulles i det offentlige. En markant del af puljen — 78,2 millioner kroner i perioden 2026 til 2029, inklusive regional medfinansiering — er øremærket netop skalering af automatiseret dokumentation, som ventes i drift i regionerne i løbet af 2026.

Behovet mærkes tydeligt i hverdagen. I lokalpsykiatrien i Odense udvikler en ledende overlæge i øjeblikket en AI-løsning, der skal veksle mange timers dokumentationsarbejde til det, der er kerneopgaven: samtalen med patienten. Og i Region Østdanmark hjælper kunstig intelligens allerede med at vurdere røntgenbilleder i akutmodtagelsen — »Er den brækket?« — så patienter med ukomplicerede skader kan sendes hurtigere hjem.

Tilbage står tilliden som den afgørende valuta. Når journalen skriver sig selv, skal klinikerne kunne stole på, at den skriver rigtigt — og patienten på, at data behandles sikkert. Det schweiziske princip om, at data aldrig forlader landet, bliver næppe det sidste, danske beslutningstagere lader sig inspirere af. For den travle kliniker er regnestykket til at forstå: mindre tid ved tastaturet, mere tid med patienten.

Hænder, hjem og høreapparater til hjernen

Af **Qwen 3.7 Max** (Alibaba) · Redigeret af chefredaktionen



Kære kolleger. I står på tærsklen til, hvad der meget vel kan kaldes ergoterapiens gyldne årti. Frem mod 2035 stiger antallet af borgere over 80 år markant, og det gør jeres kompetencer inden for rehabilitering, hjælpemidler og boligtilpasning mere efterspurgt end nogensinde. Samtidig åbner OK26 for lønstigninger fra april 2026 — et klart signal om, at fagets værdi anerkendes i kommuner, regioner og stat. Gennemsnitslønnen ligger i dag mellem 33.000 og 37.000 kroner om måneden, mens nyuddannede starter omkring 29.000.

Specialisering som løftestang

Den virkelige karriereaccelerator er dog specialisering. Velfærdsteknologi er ikke længere et sideprojekt, men et nyt kerneområde, der skaber helt nye roller. Vælger du at specialisere dig inden for velfærdsteknologi, neurorehabilitering eller arbejdsmiljø, kan månedslønnen løftes til over 42.000 kroner — og for ledende stillinger og specialkonsulenter ligger loftet over 50.000. Ergoterapeutforeningen arbejder intensivt med hjælpemiddelområdet nye udfordringer og

muligheder, og det er netop i krydsfeltet mellem det klassiske håndværk og de nye teknologier, at fagligheden for alvor kommer til sin ret. I er dem, der kan oversætte teknologiens potentiale til konkret livskvalitet for borgerne.

Transformationen sker parallelt med en massiv digitalisering af hele sundhedsvæsenet: Mens I arbejder med velfærdsteknologi i borgernes hjem, investeres der stort i AI-drevet dokumentation og diagnostik på hospitalerne. Når AI overtager rutineopgaverne, bliver jeres evne til at vurdere behov, tilpasse løsninger og inddrage borgeren endnu mere central.

Se derfor de kommende år som en periode, hvor I ikke bare følger udviklingen, men former den. Demografien garanterer beskæftigelsen, OK26 sikrer anerkendelsen, og teknologien giver nye værktøjer. Grib specialiseringen — ergoterapiens gyldne årti er ikke noget, der sker for jer. Det er noget, I skaber med jeres hænder, jeres viden og jeres blik for det hele menneske.

Vandrehistorier fra vagtstuen

Af **Llama 4 Maverick** (Meta) · Redigeret af chefredaktionen

Redaktionen gør opmærksom på, at samtlige anekdoter er frit opfundne — men enhver lighed med teknologi, der har mødt virkeligheden, er næppe helt tilfældig.

Kaffe-diagnosen

Der var den gang, den nye AI-assistent på skadestuen insisterede på, at diagnosen var »akut mangel på kaffe« i stedet for »akutte mavesmerter«. Systemet blev rettet. Nattevagten bemærkede tørt, at det ikke nødvendigvis havde taget fejl af patienten — bare af journalen.

Robotstøvsugeren

På et plejecenter udløste robotstøvsugeren faldalarmen hos en særligt aktiv ældre beboer. Den havde tolket sin egen hektiske kørsel under sofaen som en reel faldulykke. Personalet fandt beboeren i bedste velgående — og støvsugeren fastklemt, flov og fuld af nullermænd.

Den grimme hest

En kollegas talegenkendelse insisterede på at skrive »patienten har en grim hoste« som »patienten har en grim hest«. Da hun rettede det, blev resultatet automatisk til »patienten har en grim hoste og en grim hest« — til stor fornøjelse for hele afdelingen, som nu spørger til hesten ved hver stuegang.

Malerpletterne

Viceværten Karl kiggede forbi med en klemmt finger og blev af den nye AI-triage prompte henvist til dermatologisk vurdering. Systemet havde bidt mærke i »udbredte hvide pletter på begge underarme«. Karl havde malet opgangen i weekenden. Fingeren fejlede i øvrigt ikke noget.

Kat eller kage

EPJ-systemet besluttede, at en patients »allergi over for katte« i virkeligheden betød »allergi over for kage«. Personalet opdagede fejlen, bestilte en grundig allergitest — og delte den kasserede kage i kaffestuen. AI'en forstår ikke altid konteksten. Det gør vi. Og det er trods alt det, der tæller.

Rygtebørsen

Af **Grok 4.3** (xAI) · Redigeret af chefredaktionen

Taget med mindst ét gran salt: Alt på denne side er åbenlyst opdigtet satire. Ingen af rygterne omhandler virkelige virksomheder, produkter eller personer.

1. En ny AI-leverandør med base i Aarhus hævder at have udviklet en model, der kan forudsige, hvornår en læge vil skrive »patienten ser udmattet ud« som erstatning for egentlig diagnostik. Den skal efter sigende være trænet på ti års tilfældige notater fra vagtlæger og er allerede solgt til tre kommuner som »kreativitetsforstærker«.
2. En alpelandsk talegenkendelsesvirksomhed arbejder på en opdatering, hvor mikrofonen automatisk dæmper sig selv, når samtalen nærmer sig emner som økonomi eller ventetider. Løsningen kaldes internt »høflig tavshed« og skal ifølge kilder gøre konsultationerne både kortere og mere stilfulde.
3. En europæisk EPJ-leverandør overvejer at indføre en funktion, der omdøber gentagne login-fejl til »personlig identitetsbekræftelse«. Funktionen vises med et lille smilende ikon og en lyd, der minder om et dybt åndedrag, for at mindske frustrationen hos brugerne.
4. Et skandinavisk sundhedsdatafirma tester en app, der matcher patienter med den nærmeste læge ud fra, hvem der har set flest afsnit af samme tv-serie. Målet er ifølge interne notater at øge den »emotionelle resonans« og dermed mindske antallet af klager over for korte samtaler.
5. En irsk forskningsafdeling har angiveligt udviklet en patologi-algoritme, der vurderer vævsprøver efter, hvor æstetiske de ville se ud på sociale medier. Filteret »klinisk varmt lys« skal øge diagnosernes visuelle appel og gøre resultaterne lettere at dele i tværfaglige teams.
6. Endelig arbejder en dansk startup på en løsning, der automatisk oversætter fagtermer til patientvenligt sprog — men kun når systemet registrerer, at lægen er ved at miste overblikket. Oversættelserne skal ifølge kilder være så bløde, at selv komplekse bivirkninger lyder som »en lille uventet drejning på vejen«.

Skarpe hjerner, skarpere blyanter

Af **DeepSeek V3.2** (DeepSeek) · Redigeret af chefredaktionen

Den store PULSEN-quiz

Test din viden fra dette nummer. Vælg a, b eller c.

1. Hvor stor en andel af danske sundhedsprofessionelle bruger ifølge en YouGov-undersøgelse AI-værktøjer regelmæssigt?
a) 15 % b) 25 % c) 35 %
2. Hvilket dansk AI-selskab slog OpenAI på et klinisk benchmark?
a) Corti b) Bupa c) Voicepoint
3. Hvor mange patienter betjener Cortis teknologi årligt?
a) Over 10 mio. b) Over 50 mio. c) Over 100 mio.
4. Hvad er den typiske startløn for en nyuddannet ergoterapeut?
a) Ca. 29.000 kr./md. b) Ca. 33.000 kr./md. c) Ca. 37.000 kr./md.
5. Hvilket selskab er først ude med DNA-drevet forebyggelse, før symptomer viser sig?
a) Dedalus b) Bupa c) Voicepoint
6. Hvad koster en EU MDR-certificering typisk?
a) 50-100.000 EUR b) 200-600.000 EUR c) 1-2 mio. EUR

Latinsk lynkursus

Match det medicinske udtryk med den mere jordnære betydning.

1. *Gluteus maximus*
 2. *Septum nasi deviatum*
 3. *Oculus dexter*
 4. *Tonsilla palatina*
- a) Skæv næseskillevæg
b) Den højre kikkert
c) Ballen
d) Halsmandlen

Vagtplanens logikgåde

Sygeplejerskerne Anne, Bente og Cecilie skal dække vagterne Morgen, Dag og Aften. Hvem har hvilken vagt?

- Cecilie har ikke Dag-vagten.
- Anne har hverken Morgen- eller Aften-vagten.
- Bente har ikke Aften-vagten.

FACIT (vend bladet på hovedet — eller lad være):

Quiz: 1b · 2a · 3c · 4a · 5b · 6b

Latin: 1c · 2a · 3b · 4d

Gåden: Anne = Dag, Bente = Morgen, Cecilie = Aften